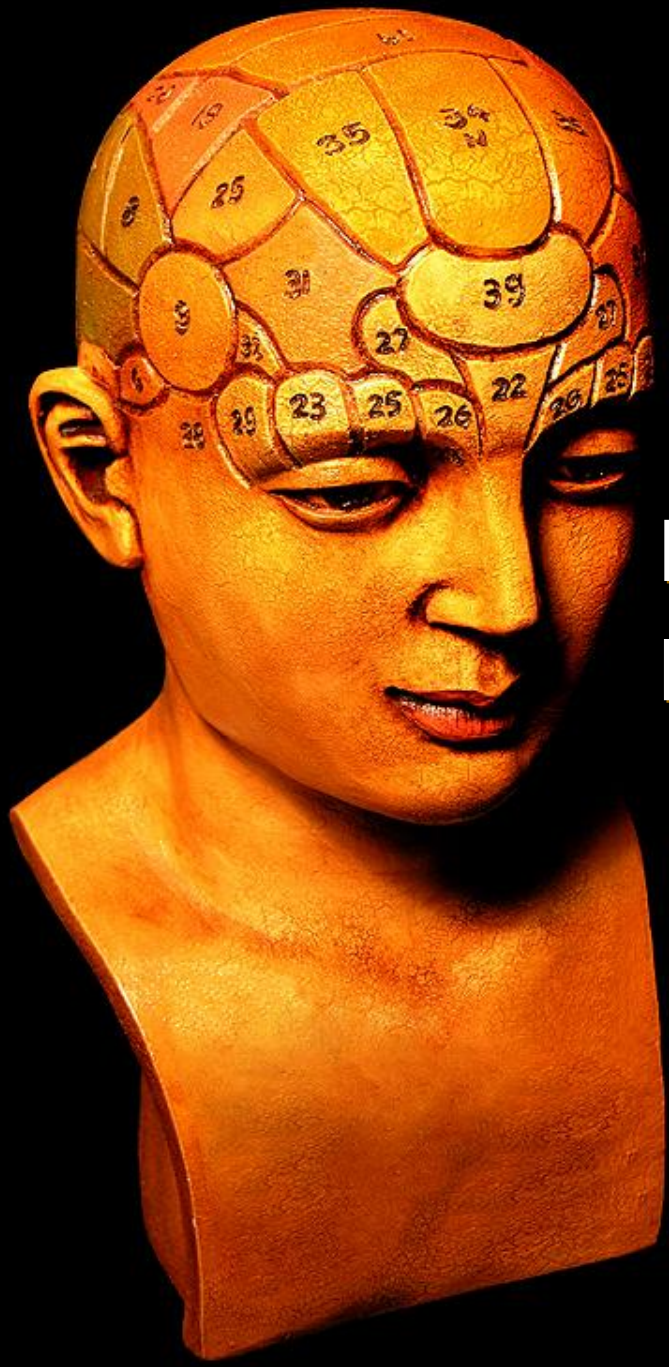


Dalla sensazione alla percezione

Doc. Rasit Sadiki, psicologo
CPS-SSPSS
CPS-SSPSS, Giubiasco
MC-SUPSI

Sensazione vs percezione

- Non sono termini sinonimi ma sono complementari
- I psicologi tendono a distinguere tra i due in base ai rispettivi processi alla base.
- Sono due processi psico-fisici che rendono possible afferrare l'esperienza, il vivere.



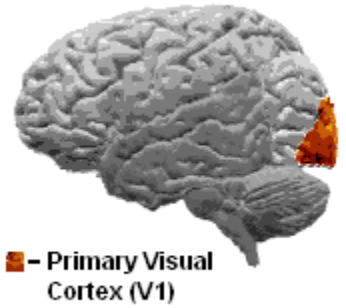
La sensazione

- Si riferisce al processo elementare di ricevere stimoli attraverso gli organi di senso e convertirli in segnali neurali che vengono poi inviati al cervello per l'elaborazione. È il primo passo nella nostra esperienza del mondo, dove gli stimoli esterni o interni vengono rilevati e trasformati. (fisiologico, organi di senso, nervi, cervello).

- Esempio:

Sensazione visiva: La luce (onde elettromagnetiche o radiazioni), colpisce la retina degli occhi, poi attraverso il nervo ottico trasmette il messaggio alla area visiva della corteccia celebrale.

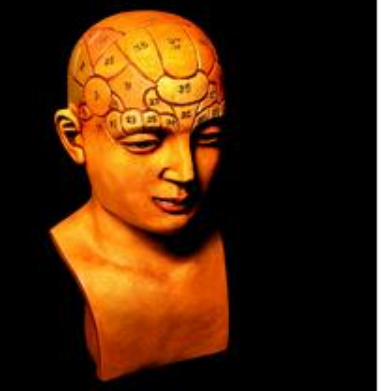




La percezione

- La elebaorazione del messaggio ricevuto/giunto alla corteccia cerebrale e quindi la trasformazione dello stesso (di ciò che vede ad esempio) in una rappresentazione mentale.

- È un fenomeno complesso che non dipende solo dal nostro sistema nervosa ma anche dalla personalità del soggetto, la sua esperienza di vita, dal suo percorso formativo, dal suo inconscio (paure, aspettative, bisogni) e esperienze particolari vissute.



Sensazione e percezione per una visione “globale”

Cosa vedete?



* Giuseppe Arcimboldo







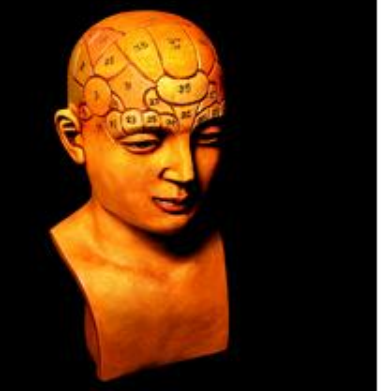
Sensazione e percezione per una visione “globale”



1. La mente percepisce questi elementi assemblati insieme come una FORMA

2. La mente attribuisce a questa FORMA:

- un senso (il volto di una persona)
- delle qualità psicologiche (aspetto sereno, emozioni varie, furbo, pensieroso, deluso ecc.) in base ai nostril schemi mentali.

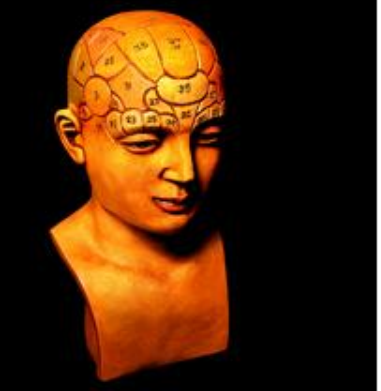


Conclusione:

Noi non percepiamo istintivamente e immediatamente in modo analitico ma in modo GLOBALE.

I psicologi della GESTALT, che studiarono la percezione giunsero quindi a stabilire una delle regole della percezione: *“Il tutto è diverso dalla somma delle parti”*

Le qualità psicologiche che noi attribuiamo al volto sono una rielaborazione personale della visione. (in base alle nostre esperienze, vissuto, personalità ecc…



Elaborazione Top-Down (dall'alto verso il basso)

- **Punto di partenza:** La conoscenza pregressa, le aspettative e i concetti.
- **Processo:** Utilizza la memoria, l'attenzione e altri processi cognitivi per dare un senso agli stimoli sensoriali.
- **Esempio:** Riconoscere una parola difficile in un paragrafo leggendo l'intero contesto, invece di concentrarsi sulle singole lettere.



Elaborazione Bottom-Up (dal basso verso l'alto)

- **Punto di partenza:** Gli stimoli esterni e le informazioni sensoriali raccolte dai sensi.
- **Processo:** Trasporta le informazioni sensoriali al cervello, che le organizza per formare una percezione globale, un elemento alla volta.
- **Esempio:** Vedere un fiore e il cervello analizza le sue caratteristiche (colore, forma) per riconoscerlo come un fiore.



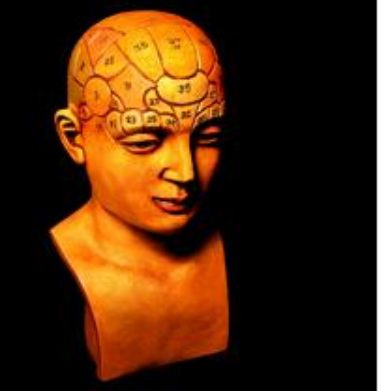
In sintesi

- Il top-down è guidato dai concetti, dal significato e dalla memoria.
- Il bottom-up è guidato dai dati sensoriali e dalle caratteristiche dello stimolo.
- Entrambi i processi lavorano insieme per una percezione complementare



Cosa vedi?





Test di rorschach

Test di personalità proiettivo, 10 tavole con delle macchie tutte diverse e alcune a colori.

- Il principio su cui si basa è la relazione tra percezione visiva e conflitti inconsci individuali.
- Lo psicologo osserva attentamente le interpretazioni (sensazioni e percezioni) date per investigare la personalità profonda del soggetto (conflitti inconsci, bisogni inconsapevoli, anise, paure, traumi ecc.).



Perché è importante per noi?

- La percezione non è una copia fedele della realtà, ma una costruzione soggettiva influenzata da esperienze, emozioni, cultura, stato fisico e mentale.

- Capirlo significa, non giudicare o sottovalutare le reazioni del paziente o dell'utente, che possono sembrare "esagerate" o "incomprensibili" ma sono coerenti con la sua percezione del mondo.



- Esempio: un anziano con decadimento cognitivo può percepire un’iniezione come una minaccia; per lui il dolore o la paura sono reali, anche se oggettivamente minimi
- «Ti accompagnano in sala pranzo» potrebbe equivalere «ti porto via con me da casa tua»
- Ecc…



Esempio: un anziano con decadimento cognitivo può percepire un’iniezione come una minaccia; per lui il dolore o la paura



La relazione d'aiuto passa attraverso la percezione reciproca

- L'infermiere o l'educatore **viene percepito** dal paziente o dall'utente attraverso il tono di voce, lo sguardo, il contatto fisico, l'atteggiamento.
- Conoscere i meccanismi percettivi aiuta a **modulare la comunicazione non verbale** e a creare un clima di fiducia.



Esempi:

- Un sorriso o un tono rassicurante possono modificare la percezione del dolore o della minaccia.

- La coerenza tra parole e gesti riduce l'ambiguità percettiva e quindi l'ansia dell'assistito.



Gestire il dolore, la fatica e lo stress passa anche dalla percezione

- La percezione del dolore, della fatica o del disagio **non dipende solo dallo stimolo fisico**, ma anche da fattori psicologici: attenzione, emozioni, aspettative, contesto.

- Il professionista può quindi **intervenire non solo sul corpo, ma anche sull'esperienza percettiva** della persona.



Esempio: distrazione, musica, tecniche di rilassamento o contatto empatico possono **ridurre la percezione del dolore**.



Percezione e comunicazione nei disturbi cognitivi o psichici

- In molte situazioni (demenza, autismo, psicosi, disturbi sensoriali) la percezione del mondo è **alterata**.

- Sapere come funzionano i processi sensoriali e percettivi aiuta a **interpretare correttamente i comportamenti** e ad adattare l'intervento educativo o assistenziale.



- Esempio: un soggetto autistico può reagire con disagio a certi suoni o luci perché li percepisce in modo amplificato.

- Un paziente con deliri o allucinazioni vive esperienze percettive “reali” per lui: negarle peggiora la relazione.



- Per entrare in relazione è essenziale **“vedere con gli occhi dell’altro”**, cioè comprendere come l’altro percepisce il mondo.
- Ciò richiede **ascolto attivo, sospensione del giudizio** e capacità di mettersi nei panni dell’utente o del paziente.

L’educatore che riconosce la prospettiva percettiva di un bambino o di un adulto fragile può adattare meglio l’ambiente e le attività.



L’infermiere, il fisioterapista o l’educatore deve conoscere i processi di **sensazione e percezione** perché il proprio intervento non agisce solo sul corpo o sul comportamento, ma anche sulla **realtà soggettiva** che ogni persona costruisce attraverso i sensi e la mente.

Capire **come le persone percepiscono il mondo** è il primo passo per **aiutarle davvero**.

